

Hiponatremia · conduta e correção

Na hiponatremia, determine tonicidade (hipo/iso/hipertônica), volemia e sintomatologia. Sintomas graves pedem salina hipertônica; crônica assintomática pede correção lenta.

Volemia guia a causa

Dica - Volemia guia a causa

Hipovolêmica: perdas + reposição hipotônica. Euvolêmica: SIADH, hipotireoidismo, glicocorticoides.

Hipervolêmica: IC, cirrose, DRC — retenção de água livre.

Confirme hiponatremia hipotônica verdadeira; depois classifique volemia (hipo/eu/hipervolêmica).

Osmolaridade serica

Primeiro passo antes de dar soro

$$\text{Osm} = 2 \cdot \text{Na} + \text{glicose}/18 + \text{ureia}/6$$

Hipotonica: Osm baixa. Hiperglicemia e pseudo (hiperlipidemia) confundem.

Conduta por gravidade

- Sintomas graves (convulsão, coma): bolus de NaCl 3% e reavaliar neurologicamente
- Moderada sintomática: correção controlada + tratar causa
- Crônica oligossintomática: restrição hídrica (SIADH), salina isotônica se hipovolêmica
- Meta usual de correção: evitar >8–10 mEq/L em 24 h (mais restrito se alto risco de ODS)

Causas frequentes em prova

Perfil | Exemplos

Hipovolêmica | Diuréticos, vômitos, perdas GI

Euvolêmica | SIADH (pulmonar/SNC/fármacos)

Hipervolêmica | IC, cirrose, síndrome nefrótica

Hipertônica | Hiperglicemia grave

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Correção excessivamente rápida da hiponatremia crônica pode causar mielinólise osmótica (ODS). Sintoma grave justifica hipertônica, mas não 'normalize o Na em horas'.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Classificar por volume e osmolaridade e respeitar limites de correção evita mielinólise osmótica.

Hipovolêmica × euvolêmica (SIADH) × hipervolêmica muda o tratamento.

Classificacao por volume

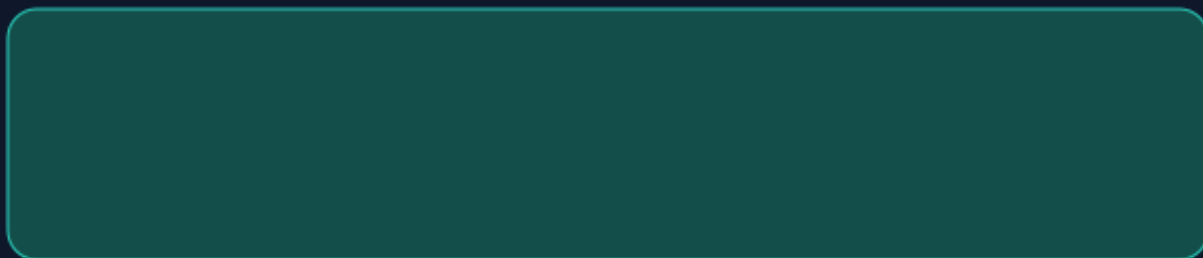
Hiponatremia hipotonica



Correção excessiva !' desmielinização osmótica (ODS).

Limites de correcao

Risco de ODS



Passo diagnóstico

Passo | Pergunta

- 1 | Osm plasmática? (hipo / iso / hiper)
- 2 | Se hipo: estado de volume?
- 3 | Osm urinária e Na urinário?
- 4 | SIADH: euvolêmico, OsmU alta, NaU tipicamente > 40, tireoide/adrenal ok

Conduta por tipo

- Hipovolêmica: SF 0,9% (ou volume isotônico)
- SIADH: restrição hídrica ± sal / vaptanos em cenários selecionados
- Hipervolêmica: restrição hídrica + tratar causa (diurético na IC)
- Sintomas graves (convulsão/coma): NaCl 3% em bolos controlados

ODS / mielinólise

Atencao - ODS / mielinólise

Risco maior em Na crônica muito baixa, alcoolismo, desnutrição, hepatopatia. Se corrigir demais: desacelere / considere DDAVP + SG conforme protocolo.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1